PROTOCOLLO 61

Stabilizzazione isometrica in lateralità

Migliorare la stabilità nei movimenti laterali

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Deviazione laterale
- ✓ Asimmetria muscolare
- ✓ Fase di consolidamento

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Bocca leggermente aperta.



Resistenza
Mano sul lato della mandibola.



Contrazione
Spingi lievemente contro la mano senza muovere.



Alternanza
Ripeti dall'altro lato.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Contrazione	5 secondi
Ripetizioni	6 per lato
Serie	2 al giorno

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Simmetria tra i lati
- ✓ Contrazioni lievi
- ✓ Postura corretta del capo

Errori da evitare

- ! Movimento della testa
- ! Forza eccessiva
- ! Trattenere il respiro

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Isometria laterale	Spinta lieve contro la mano su entrambi i lati	6 x 5 secondi per lato

! **Nota clinica.** Le isometrie laterali completano la stabilizzazione dopo il recupero del range.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.